

ANAMNÈSE

Théorie :

L'anamnèse représente l'histoire médicale du patient. Les informations sont apportées par le patient et sont censées permettre la construction d'hypothèses diagnostiques.

Motif de consultation

Anamnèse actuelle

Anamnèse par système

Antécédents personnels

Anamnèse personnelle

Antécédents familiaux

Anamnèse psycho-sociale

Les traitements

Conclusion



Maladies et accidents
actuels du patient

Facteurs de risques

Mieux connaître et comprendre le patient

Pratique :

1. Motif de consultation : souffrance/plainte ou bilan de santé
2. Anamnèse actuelle :
 - 1^{ère} question ouverte : *Qu'est-ce qui vous amène/ne va pas ? Pouvez-vous m'en dire plus ?*
 - 2^{ème} question précision/confirmation : *Qu'entendez vous par ... ?*
 - Caractériser le symptôme : *horaire, intensité, qualité, mode, associés, déclenchant, reposant, synthèse*
3. Anamnèse par système
 - a. Générale
 - i. Etat général
 - ii. Poids (gain, perte, cinétique)
 - iii. Température
 - iv. Adénopathies (ganglion gonflé)
 - v. Sudations (nocturnes)
 - vi. Allergies
 - b. Cardiovasculaire
 - c. Pulmonaire
 - i. Douleurs thoraciques
 - ii. Dyspnée (stades 1 à 4 : effort soutenu/modéré/moindre effort/au repos)
 - iii. Toux
 - iv. Expectorations (volume, sang)
 - v. Asthme (facteurs déclenchants)
 - vi. Ronflements
 - d. Digestive
 - i. Dysphagie (liquides, solides)
 - ii. Nausées, vomissements
 - iii. Pyrosis (brûlures intestinales, acidité, aigreur)
 - iv. Réplétion gastrique
 - v. Douleurs abdominales
 - vi. Selles : fréquence, qualité, incontinence
 - vii. Ictère (peau jaune => pigment biliaires dans le sang)
 - e. Génito-urinaire
 - f. Neurologique

- g. Ostéo-articulaire
- h. Dermatologique
- i. Psychiatrique
- 4. Antécédents personnels
 - a. Maladies et traitements (chronologie)
 - b. Accidents et blessures
 - c. Opérations
 - d. Hospitalisations
- 5. Anamnèse personnelle
 - a. Etat général ressenti par le patient
 - b. Vaccins
 - c. Risques liés à l'environnement
 - d. Exercice et loisirs
 - e. Habitudes alimentaires
 - f. Alcool, tabac, substances
- 6. Antécédents familiaux
 - a. Pathologies retrouvées dans la famille
 - b. Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
 - c. Pathologies chez les frères et sœurs
 - d. Pathologies chez les enfants
- 7. Anamnèse psycho-sociale
 - a. La situation à domicile
 - b. La vie au quotidien
 - c. Les expériences importantes
 - d. Les croyances religieuses
 - e. Les opinions du patient
- 8. Les traitements
 - a. Le traitement régulier
 - b. Les traitements occasionnels
 - c. Les « substances annexes » (vitamines, plantes)
- 9. Conclusion
 - a. Reprendre les points importants
 - b. Montrer que l'on a compris la plainte, les attentes
 - c. Proposer des solutions, une transmission de l'information et une prochaine séance

SKILLS NEUROLOGIQUES

REFLEXES

Les ROT sont déclenchés par exercices, en couple.

Théorie :

- rappel cotation 0 - 4+ (normal 2+ ; si >2+ = sémiologie pyramidale ; si <2+ = sémiologie périphérique).
- Niveaux métamériques des ROT limités : C6 et C7 au MS ; L4 et S1 au Mi
- marteau à tête lourde.
- évoquer 2-3 fois à 1 niveau, puis déclencher le même ROT controlatéral.

Pratique :

1. assis (biceps brachial C5-6; brachioradial C6 ; triceps brachial C7; quadriceps L4 ; Achilléen S1).

2. couché (biceps brachial ; brachioradial ; triceps brachial ; quadriceps ; Achilléen ; cutané abdominal ; cutané plantaire = Babinski si extension anormale) : Tous les ROT sont évocables du même côté du lit sauf 1 Achilléen controlatéral.
3. Eventuellement manœuvre de facilitation (Jendrassik) : contracte la mâchoire ou traction entre les deux bras.

Erreurs fréquentes: le marteau n'atteint pas la cible du tendon; il n'est pas déclenché assez fort; les ROT ne sont pas évoqués du même côté du lit ; le réflexe cutané plantaire n'est pas frotté suffisamment au bord latéral du pied.

FORCE MUSCULAIRE

La force musculaire, puis les épreuves fonctionnelles, sont appréciées par exercices, en couple.

Théorie :

- Rappel cotation force musculaire ; système MRC 0 - 5 (normal = 5, contre gravité avec maintien = 3), si < 5 = parésie ou faiblesse musculaire (MRC=Medical Research Council ou conseil scientifique britannique ayant reconnu après la 1^{ère} Guerre mondiale l'utilité d'une cotation internationale).
- La précision de l'examen est fonction des hypothèses de travail.
- Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits.

Pratique :

1. Assis, en symétrie pour les MS proximaux (sous-épineux; deltoïde ; biceps brachial ; triceps brachial ; extenseurs poignet ; fléchisseurs poignets ; extenseurs doigts ; fléchisseurs doigts ; interosseux et abd doigt V ; court abducteur du pouce ; fléchisseurs cuisse ; quadriceps ; fléchisseurs genoux).
2. Motilité fine des doigts et des orteils (reconnaissance de l'atteinte pyramidale).
3. Couché (extenseurs pied et orteils ; fléchisseurs orteils), mais les muscles examinés en position assise peuvent aussi être examinés en position couchée.
4. Épreuves fonctionnelles : Relever de la tête et du tronc ; épreuve des bras tendus et jambes fléchies ; élève les bras en dessus de la tête ; accroupissement et relever possible (si pathologique = signe de Gowers) ou épreuve du tabouret ; marche sur les pieds et les talons ; tient sur une jambe (si parésie du moyen fessier = signe de Trendelenbourg).

SENSIBILITÉS

Les différentes sensibilités, puis les épreuves fonctionnelles, sont appréciées par exercices, en couple.

Théorie :

- Rappel des différentes modalités protopathiques et épicritiques.
- Connaître les niveaux mamelons, ombilic, racines des extrémités.
- La précision de l'examen est fonction du contexte.
- Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits.

Pratique :

Examen systématique à la base unguéale des index et des gros orteils (si pas de reconnaissance, remonter proximement ; poignet/cheville ; coude/genoux).

1. Reconnaissance au piquer toucher par un coton tige cassé en 2.
2. Reconnaissance du sens position ou de arthocinétique.

3. Reconnaissance du sens de la pallesthésie (vibration).

Nota bene : Le sens de température nécessite l'utilisation de petits Erlenmeyer remplis d'eau chaude/froide. L'étude du sens de la stéréognosie (objet fin dans la main sans contrôle visuel) peut être utile dans une appréciation intégrée des sensibilités (cortex pariétal).

4. Épreuves fonctionnelles : démarche du funambule (pieds appondus l'un devant l'autre) ; épreuve de Romberg, d'abord pied serrés et bras tendus, puis fermeture oculaire ; aussi épreuve des bras tendus et jambes fléchies.

Erreurs fréquentes: les stimulations toucher/piquer sont légères et répétées au même site 2-3 fois ; les sites d'examen sont fonction des hypothèses de travail : déséquilibre à la marche (ci-dessus), dans un territoire d'innervation d'un tronc nerveux ou d'une main ; dans les troubles sphinctériens, ne pas oublier de rechercher des déficits au niveau de la queue de cheval (faces postérieures des cuisses et des jambes, fesses et périnée).

SKILLS AUDITION

Théorie :

L'amplification créée par le conduit auditif externe, le tympan et les osselets induisent que l'on entend mieux un son externe qu'en vibration direct sur notre corps.

Pratique :

1. Désinfection des mains
2. Observation du conduit auditif (ex. oreille droite)
 - a. Se tenir à droite du patient
 - b. Lui faire pencher la tête sur le côté puis tourner légèrement à droite
 - c. Lever son oreille avec la main gauche
 - d. Insérer l'otoscope lentement avec la main droite
 - e. Observer le tympan et le triangle lumineux dans le quart antéro-inférieur
3. Test de Rinne et test de Weber, vibration sur le processus mastoïde puis devant l'oreille : le patient doit entendre à nouveau le son. Vibreur placé sur le crâne médialement : le son ne doit pas être latéralisé.

Weber: on entend mieux du côté atteint quand c'est une surdité de transmission. (rinne négatif là où on entend Weber)

Si on a une surdité de perception: on va avoir le côté atteint là où on entend pas Weber, et Rinne sera bien des 2 cotés

SKILLS VISION

Pratique :

1. On demande au patient de fixer notre nez
2. On approche sa main de son champ visuel : le patient mentionne dès qu'il l'aperçoit (détection d'hémianopsie, etc)
3. Test de la différenciation des couleurs (cahiers de chiffres)
4. Test d'acuité avec lettres à distance
5. Test de convergence (accommodation) : on montre un objet de loin, puis de près.

tableau acuité visuelle:

si chiffre (6/60) il devrait être capable de voir normalement ce E à 6 mètres.

- champs visuel par confrontation: cacher un oeil et nous m^me aussi cacher l'oeil miroir., fixer mon nez, on test les 4 cadrans de chaque oeil.

SKILLS TENSION ARTÉRIELLE ET POULS

Théorie :

La systole est le moment d'éjection du sang dans la circulation : la pression est maximum. La diastole à l'inverse a la pression minimum et représente le moment de remplissage du ventricule et de fermeture des valves atrio-ventriculaires.

Pratique TA :

1. Désinfection des mains
2. Manomètre face à nous, sans fuite d'air et avec la graduation à zéro
3. Patient calme, décontracté, silencieux, assis et bras libre.
4. Face à la colonne, repérer la zone de battement max de l'artère humérale (FC humérale)
5. Poser le brassard à 2-3 cm au dessus du pli du coude
6. Gonfler le brassard pour une première estimation (pression systolique)
7. Nouveau gonflage 30 mmHg au dessus de la pression systolique
8. Dégonfler à 2 mmHg/s en mesurant la systole et la diastole
9. Mesure de la FC

Pratique Pouls :

1. Désinfection des mains
2. Prendre chaque fois les pouls 15 sec. de chaque côté. Prendre 60 sec. si irrégulier.
3. Pouls carotidien (pas trop longtemps, un côté à la fois, ne pas massé)
4. Pouls radial
5. Pouls huméral = brachial
6. Pouls tibial (derrière la malléole **int**)
7. Pouls pédieux (entre 1^{er} et 2^{ème} métatarsien, parfois absent)

Prendre la fréquence cardiaque au pouls radial.

On a aussi le pouls: fémoral, poplité

SKILLS AUSCULTATION CARDIAQUE

Théorie :

Il existe 4 foyers de mesure représentant chacun une valve : valve aortique (2^{ème} intercostale dt.), valve pulmonaire (2^{ème} intercostale g.), valve tricuspide (4^{ème} intercostale) et valve mitrale (5^{ème} intercostale, médio-claviculaire)

Le bruit cardiaque se divise en deux : toum et tac. Le premier son B1 plus long et plus grave représente le début de la systole et la fermeture des valves atrio-ventriculaire. Il est mieux perçu à la pointe et est synchrone avec le pouls.

B2 représente le début de la diastole et la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Il est plus court et plus sec (tac). Lors de l'inspiration profonde, B2 se dédouble en deux bruits A2 et P2 qui représentent les valves aortiques et pulmonaires. Elles se mesurent respectivement à l'apex et à la base.

Pratique :

Inspection

1. Désinfection des mains
2. A droite du patient torse-nu
3. Symétrie du thorax, cicatrice, aspect de la peau, pulsation visible

Palpation

4. FC et FR
5. Pouls carotidien droite et gauche en parallèle de l'écoute (synchrone avec B₂)
6. Choc de pointe/apexien sur la 5^{ème} intercostale médio-claviculaire. Plus prononcé en position latérale.

(pas B2) avec B1 (fermeture des valves atrio-ventriculaire,

lors de l'ejection du sang dans la circulation, systole!

Auscultation

7. Ecoute au diaphragme des 4 foyers en faisant un trajet en Z (2.2.4.5). Différencier B1 et B2
8. Ecoute à la cloche de la mitrale et la tricuspide
9. Différencier A2 et P2 en écoutant sur le foyer pulmonaire, en demandant au patient d'inspirer profondément

écouter la carotide pour détecter d'éventuel souffles
carotidiens

SKILLS AUSCULTATION PULMONAIRE

Théorie :

En principe le poumon doit avoir une sonorité spécifique. Le cas inverse, il peut avoir un emphysème (sonorité tympanique/creuse comme l'intestin) ou un surplus de mucus (sonorité mate/pleine comme le foie).

Pratique :

1. Désinfection des mains
2. Patient couché sur le dos

Inspection

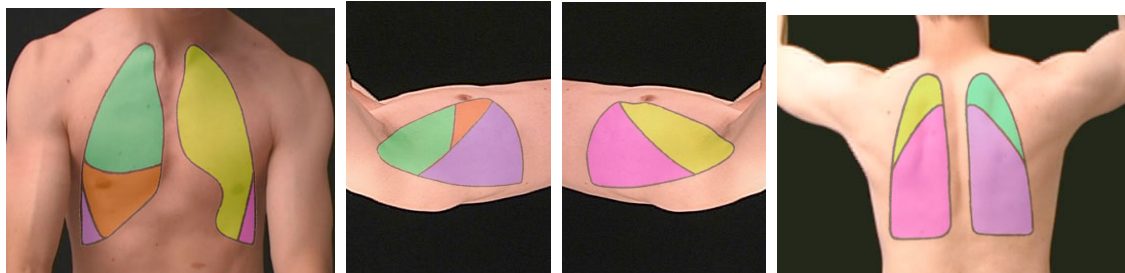
3. Détresse respiratoire : cyanose, bruits, efforts musculaires (sterno-cléido)
4. Formes du thorax : asymétrie, déformation, creux
5. Mouvements respiratoires : symétrie, expansion thoraco-abdominale, abdomen surtout
6. Fréquence respiratoire sur 30 s, N = 10-20 par minute

Palpation

7. Ganglions mandibulaires, cervicales, sus-claviculaires et axillaires par "pianotage" des doigts ^{axillaire}
8. Anomalies visibles et zones douloureuses. Approche progressive.
9. Apposition des mains sur l'abdomen, pousse au centre et au-dessus (sous 10^{ème} côte) afin de vérifier la symétrie d'ampliation

Percussion

10. Tapotement avec le majeur droite sur l'articulation distale du majeur gauche bien appuyé sur le thorax du patient. Son normalement intermédiaire : ni tympanique, ni mate. ^{sonorité}
11. Tapoter en symétrie en descendant. *Attention* à la matité du cœur. S'arrêter à la matité du foie à droite et le tympanisme de l'intestin à gauche.



Auscultation

12. Ecouter avec le stéthoscope en symétrie et en descendant. Son homogène et régulier comme le bruit de la mer.
13. Recommencer pour le dos avec le patient dans la position assis.

écouter la trachée

SKILLS STATUS DIGESTIF

Théorie

Connaître les 9 régions de l'abdomen :

Hypochondre droit	Epigastre	Hypochondre gauche
Flanc droit	Région ombilicale	Flanc gauche
Fosse iliaque droite	Hypogastre	Fosse iliaque gauche

Pratique

Position du patient :

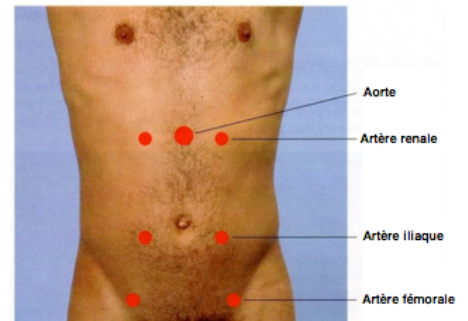
1. couché avec les 9 cadrans déshabillés, détendu, jambe légèrement pliée et bien éclairé

Observation:

2. le visage : malaise, douleur
3. la peau : cicatrices, vergetures (sorte de cicatrice par déchirure), veines dilatées, lésions cutanées, autres ...
4. allure de l'abdomen : symétrie, plat, arrondi, protubérance
5. mouvements : respiratoires, péristaltiques, pulsatiles

Auscultation : bruits anormaux, souffles vasculaires,

6. Etudier la motilité intestinale
7. Sténose rénale éventuelle (sur point rouge)
8. Occlusions vasculaires



Percussion : le long de la ligne médio-axillaire

9. Droite : matité : foie > tympanique : organes digestifs
10. Gauche : tympanisme : poche d'air gastrique

Palpation : demander au patient d'indiquer les zones douloureuses palpation légère et profonde

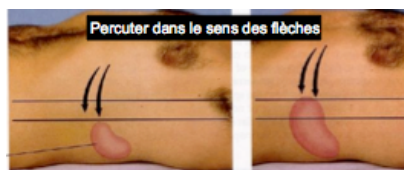
11. Avec la pulpe des doigts, une main posée, l'autre qui appuie dessus : recherche de masses, dureté
12. Test de détente : relâche soudainement la pression apposée

Examen par organes

13. Foie : main gauche dans le dos, sous le foie, parallèlement aux deux dernières côtes / main droite appuie vers le foie avec la pulpe des doigts / Demander au patient de respirer profondément
14. Rate : percussion latéralement et en allant de plus en plus dorsalement / Palpation main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche / main droite: sous le rebord costal gauche, appuie en direction de la rate / Demander au patient d'inspirer profondément



les reins: palpation profonde
et percussion (assis)



SKILLS STATUS ARTICULAIRE

Théorie

Le status articulaire mesure la performance des articulations en degré ou tout simplement en résistance à une force imposée. On parle d'actif et de passif :

Actif : le patient va au maximum et on mesure

Passif : le patient se laisse faire par le soignant (valeur passif > actif)



VARUS



VALGUS

Pratique

Epaule

1. Flexion: main en supination. Goniomètre sur scapula et membre
2. Extension : idem. Avec coude plié = pas d'ambiguïté
3. Abduction : jusqu'à bascule de la scapula
4. Adduction : bras dans le dos, pas mesuré
5. Rotation ext. : bras le long du corps, coude plié, main en supination
6. Rotation int. : main sur le ventre, pouce sur xyphoïde, force mise par le soignant : le patient doit essayer de rapprocher la main de son ventre (belly press) OU main dans le dos : le patient doit essayer d'éloigner sa main de son dos (lift oft)

Genou

1. Flexion : mesure de l'angle
2. Repos : en principe 0° sauf si pathologique
3. Extension : mesure de l'angle (quelques degrés)

Laxité

1. Cheville dans les mains : on les colle ensemble, condyles doivent toucher aussi. Eventuel varus ou valgus.
2. Jambe étendue dans les mains, patient relâche ses muscles. On teste laxité interne et externe : normalement nul avec jambe étendue
3. Jambe pliée légèrement (10-30°). Même test : normalement légère laxité (externe > interne)